

3 讨论

随着肺结核患者呈日趋高龄化、患病率在全球范围内的回升及肺癌患病率日渐增高,肺结核合并肺癌患者例数亦与日俱增^[1]。而肺结核痊愈后肺部遗留的瘢痕可能会发生癌变,由于肺癌患者免疫抵抗力低下也会并发或使肺内原有病灶复发,从而重复感染肺结核。因肺结核和肺癌的临床症状、体征及 X 线片表现有相似性,当两者痰涂片及痰培养均未检测出结核菌时更不易区分,导致两者常在鉴别上出现差错^[2]。健康机体和某些良性疾病也能少量合成或分泌胸水,结核性胸膜炎与恶性肿瘤等疾病常有渗出性胸水,为准确鉴别肺结核与肺癌,需分析胸水性。癌细胞是肺癌诊断的金指标,但阳性检出率不高。抗酸杆菌和结核菌培养是结核性胸水的病原学诊断标准,但检出率低且耗时较长。

CRP 是一种急性时相反应蛋白,由肝脏合成,健康人群血清中含量很低,一般<10mg/L,当机体发生感染、组织损伤、自身免疫性疾病、恶性肿瘤等疾病时,血浆中含量急剧升高,激活补体系统,加强细胞吞噬等,清除入侵机体的外来病原体,因而常被作为临床感染和组织损伤等疾病诊断、疗效观察和预后判断的重要指标^[3]。有研究认为,炎症前细胞因子白细胞介素-6 (IL-6)、白细胞介素-1b (IL-1b) 和肿瘤坏死因子- α (TNF- α) 可影响血清中 CRP 的生成^[4],而这些细胞因子与恶性肿瘤的生物学行为密切相关,可能是导致恶性肿瘤患者血清 CRP 水平升高的生理学机制之一。本文结果显示,肺结核组患者胸水和血清 CRP 浓度明显高于肺癌组,差异有统计学意义。可能与结核分枝杆菌入侵机体产生炎症反应,导致大量细胞因子与介质释放参与机体防御过程,从而使血清 CRP 浓度升高;肺癌组患者因为炎症不明显,不能刺激 CRP 明显增高,所以胸水及血清中 CRP 水平升高幅度不如肺结核患者明显。

ADA 是嘌呤核苷代谢中的重要酶之一,可催化腺嘌呤核苷酸转变为肌苷,再在酶的作用下生成次黄嘌呤,最终生成代谢的终产物尿酸。ADA 在人体各种细胞及体液中广泛存在,与机体的免疫功能密切相关,以胸腺、脾和其他

组织中含量最高,其中淋巴细胞中 ADA 含量超过红细胞 10 倍,T 细胞中含量又比 B 细胞高,未分化的原始细胞内含量更高。ADA 已应用于胸腹水良恶性鉴别及慢性肝炎、肝纤维化诊断等方面。当机体有肺结核或肺癌时细胞免疫启动,T 淋巴细胞增殖,导致胸水及血液里的 ADA 含量明显上升^[5]。有研究提示,ADA 在良性胸腹水(特别是结核菌感染时)中活性明显上升;而在恶性胸腹水中活性不高^[6]。本文结果显示,肺结核组患者胸水及血清 ADA 水平均较正常参考范围明显升高,显著高于肺癌组,所以检测 ADA 对肺结核与肺癌的鉴别诊断有较大意义。

综上所述,血清与胸水 ADA、CRP 水平在肺结核和肺癌患者中差异明显,两指标联合检测有助于鉴别诊断两种疾病。

参 考 文 献

- [1] Fu T, Xie J. Progress on the biomarkers for tuberculosis diagnosis[J]. Crit Rev Eukaryot Gene Expr, 2011, 21(4): 379.
- [2] 吴丽光,方碧洪,林淑娟. 不典型肺结核 50 例 X 线影像分析[J]. 福建医药杂志, 2013, 35 (4): 124.
- [3] Hefler LA, Concin N, Hofstetter G, et al. Serum C-reactive protein as independent prognostic variable in patients with ovarian cancer[J]. Clin Cancer Res, 2008, 14 (3): 710.
- [4] Allin KH, Nordestgaard BG. Elevated C-reactive protein in the diagnosis, prognosis, and cause of cancer[J]. Crit Rev Clin Lab Sci, 2011, 48(4): 155.
- [5] 代平. 胸腔积液 ADA、CEA 检测对结核和恶性胸腔积液的诊断价值[J]. 实用临床医学, 2011, 12(2): 14.
- [6] Sakuraba M, Masuda K, Hebisawa A, et al. Pleural effusion adenosine deaminase(ADA) level and occult tuberculous pleurisy[J]. Ann Thorac Cardiovasc Surg, 2009, 15(5): 294.

(收稿:2014-05-08)

(发稿编辑:杨海陆)

哪些药品容易出现药物相互作用?

治疗窗范围窄的药物(即剂量稍有变化药理作用即有明显改变的药物),需要监测血药浓度的药物,酶诱导剂和酶抑制剂都容易发生药物相互作用。它们包括口服抗凝药、口服降糖药、抗生素类、抗癫痫药、抗心律失常药、强心苷和抗过敏药等。